



Douleur oculaire

Par [Christopher J. Brady](#), MD, Larner College of Medicine, University of Vermont

Reviewed By [Sunir J. Garg](#), MD, FACS, Thomas Jefferson University

Vérifié/Révisé oct. 2025

La douleur oculaire peut être décrite comme aiguë, sourde, ou pulsatile et doit être distinguée d'une irritation superficielle ou d'une sensation de corps étranger. Dans certaines affections, la douleur est aggravée par la lumière intense. La douleur oculaire peut être provoquée par une maladie grave et nécessite un examen rapide. De nombreuses causes de douleur oculaire provoquent également un œil rouge.

Physiopathologie de la douleur oculaire

La cornée est richement innervée et hautement sensible à la douleur. Beaucoup de maladies qui affectent la cornée ou la chambre antérieure (p. ex., [uvéïtes](#)) provoquent également des douleurs par spasme du muscle ciliaire; quand ce spasme est présent, la lumière intense provoque la contraction musculaire, et aggrave les douleurs.

Étiologie de la douleur oculaire

Les maladies qui provoquent des douleurs oculaires peuvent être classées entre celles qui touchent principalement la cornée, puis les autres pathologies oculaires et enfin les atteintes qui provoquent une douleur projetée à l'œil (voir tableau [Certaines causes de douleur oculaire](#)).

Les causes **les plus fréquentes** sont les suivantes:

- [Abrasion de la cornée](#)
- [Corps étrangers](#)

Cependant, la plupart des troubles cornéens peuvent provoquer des douleurs oculaires.

Un prurit ou une sensation de corps étranger peut être provoqué par un trouble conjonctival ou cornéen.

TABLEAU

Certaines causes de douleur oculaire

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
Troubles touchant principalement la cornée [†]		
Kératite des lentilles de contact	Douleur oculaire, sensation de sable dans l'œil, port prolongé de lentilles de contact, yeux rouges des deux côtés, larmoiement, œdème cornéen	Anamnèse et examen clinique, comprenant un examen ophtalmique en cas de perte de vision
<u>Érosion cornéenne ou corps étranger</u>	Habituellement, antécédents connus de traumatisme ou d'activités à haut risque telles que le meulage de métal, de douleur unilatérale au clignement, de sensation de corps étranger Parfois, un facteur prédisposant tel qu'un <u>trichiasis</u> (cils touchant la cornée) Lésion ou corps étranger visibles à la lampe à fente	Anamnèse et examen clinique, comprenant un examen ophtalmique, avec éversion des paupières
<u>Ulcère cornéen</u>	Douleur sourde, sensation de corps étranger, photophobie, œil rouge, opacité grisâtre sur la cornée, centrée par un cratère visible Possibles antécédents de sommeil avec des lentilles de contact en place	Grattage pour culture (effectué par un ophtalmologiste)
<u>Kératoconjonctivite épidémique</u> (conjonctivite adénovirale avec kératite) dans sa forme grave	Douleur oculaire, sensation de sable dans l'œil, rougeur oculaire bilatérale, écoulement aqueux abondant, lymphadénopathie pré-	Anamnèse et examen clinique, comprenant un examen ophtalmique en cas de perte de vision

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
	auriculaire, chémosis (gonflement de la conjonctive), souvent œdème de la paupière Colorations cornéennes ponctuées au test à la fluorescéine	
<u>Zona ophtalmique</u>	Précoce: vésicules et croûtes unilatérales sur une base érythémateuse distribuées dans le territoire du V1, affectant parfois le bout du nez Œdème palpébral, œil rouge Tardif: rougeur, douleur très sévère Fréquemment associé à une <u>uvéite</u>	Bilan ophtalmologique Culture virale si le diagnostic est incertain
<u>Kératite herpétique</u>	Aiguë: début après une <u>conjonctivite</u>, phlyctènes sur la paupière Aiguë tardive ou récurrente: lésion cornéenne dendritique classique à la lampe à fente Habituellement unilatérale (peut être bilatérale chez les enfants ou les patients atopiques)	Anamnèse et examen clinique, comprenant un examen ophtalmologique Culture virale si le diagnostic est incertain
Coup d'arc (soudeurs) ou <u>ophtalmie des neiges</u>	Début plusieurs heures après une exposition excessive à un rayonnement UV (p. ex., à un arc électrique de	Anamnèse et examen clinique, comprenant un examen ophtalmique si le diagnostic est incertain

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
	soudure ou à un soleil vif sur la neige) Bilatéral; douleur oculaire, sensation de sable dans l'œil Rougeur marquée et colorations ponctuées au test à la fluorescéine à l'examen de la cornée	
Autres troubles oculaires		
<u>Glaucome aigu par fermeture de l'angle</u>	Violente douleur oculaire, céphalées, nausées, vomissements, halos autour des lumières, flou cornéen (provoqué par un œdème), rougeur importante Pression intraoculaire habituellement > 30-35 mmHg	Gonioscopie par un ophtalmologiste
<u>Uvéite antérieure</u>	Douleur oculaire, cercle périkératique (flush ciliaire), photophobie, souvent un facteur de risque (p. ex., affection auto-immune, post-traumatique) Signe de Tyndall à la lampe à fente Rarement, hypopion	Bilan ophtalmologique
<u>Endophtalmie</u>	Douleur oculaire, hyperhémie conjonctivale intense, photophobie, diminution de l'acuité visuelle très importante, facteurs de risque (une chirurgie intra-oculaire, un	Bilan ophtalmologique et tests microbiologiques immédiats (p. ex., coloration de Gram et culture des aspirats à la recherche d'une endophtalmie endogène,

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
	traumatisme ou un bactériémie récents) Unilatérale Signe de Tyndall et souvent hypopion à la lampe à fente	hémocultures et urocultures)
<u>Névrite optique</u>	Légère douleur, qui peut s'aggraver lors des mouvements oculaires Baisse de vision, allant d'un petit scotome jusqu'à la cécité Déficit pupillaire afférent (un signe particulièrement caractéristique si l'acuité visuelle est préservée) Paupières et cornée normales, parfois papille œdémateuse	Envisager une IRM au gadolinium du cerveau et des orbites pour rechercher un œdème du nerf optique et des lésions démýélinisantes dans le cerveau (le plus souvent dus à une <u>sclérose en plaques</u>)
<u>Cellulite orbitaire</u>	Douleur oculaire ou périoculaire persistante, paupières rouges et gonflées, exophtalmie, anomalie des mouvements oculaires, baisse de l'acuité visuelle, fièvre Unilatéral Parfois, précédée par des symptômes de sinusite	TDM ou IRM des orbites
<u>Pseudotumeur orbitaire</u>	Douleur persistante oculaire ou périoculaire (peut être très sévère), exophtalmie unilatérale Anomalie des mouvements oculaires,	TDM ou IRM des orbites Biopsie

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
	œdème péri-orbitaire, début progressif	
<u>Sclérite</u>	Douleur très sévère (souvent décrite comme lancinante), photophobie, larmoiement, plaques rouges ou violacées sous la conjonctive bulbaire, œdème scléral Souvent antécédent d'affection auto-immune	Bilan ophtalmologique
Troubles provoquant des douleurs projetées		
<u>Algies vasculaires de la face (céphalée en grappe)</u>	Épisodes antérieurs, schéma chronologique caractéristique (p. ex., groupe d'épisodes à la même heure chaque jour) En coup de couteau, rhinorrhée, larmoiement, flush du visage	L'anamnèse et l'examen clinique
<u>Migraines</u>	Épisodes antérieurs, aura, douleur pulsatile, nausée, parfois photosensibilité ou photophobie	Anamnèse et examen clinique, comprenant un ophtalmologique et parfois une IRM ou une TDM du cerveau (p. ex., en cas de début après 40 ans ou de signes neurologiques atypiques)
<u>Sinusite</u>	Parfois, œdème périorbitaire mais examen oculaire sans autre particularité Rhinorrhée purulente, douleurs oculaires ou faciales qui varient avec la position de la tête	Parfois, TDM

Cause	Signes évocateurs	Procédure diagnostique*
	Sensibilité faciale, fièvre, parfois toux nocturne productive, haleine fétide	
*Le bilan ophtalmologique doit comprendre un examen à la lampe à fente, un test à la fluorescéine et une tonométrie oculaire.		
†La plupart des patients ont un larmoiement et une photophobie véritable (une lumière orientée sur l'œil indemne provoque une douleur dans l'œil malade alors qu'il est fermé).		
UV = ultraviolet; V1 = branche ophtalmique du nerf trijumeau.		

Évaluation de la douleur oculaire

Anamnèse

L'**anamnèse de la maladie actuelle** doit préciser le début, le type et la sévérité de la douleur et tout antécédent d'épisodes antérieurs (p. ex., groupes d'épisodes quotidiens). Les symptômes associés importants comprennent une photophobie vraie (une lumière dirigée sur l'œil indemne provoque une douleur dans l'œil malade alors qu'il est fermé), une diminution de l'acuité visuelle, une sensation de corps étranger et une douleur au clignement et une douleur lors des mouvements du globe.

La **revue des systèmes** doit rechercher les symptômes d'une maladie causale, dont la présence d'une aura ([migraine](#)); de la fièvre et des frissons (infection); et une douleur provoquée par les mouvements de la tête, une rhinorrhée purulente, ou une toux nocturne ou productive et une haleine fétide ([sinusite](#)).

La **recherche des antécédents médicaux** doit porter sur des maladies constituant des facteurs de risque de douleur oculaire, dont des maladies auto-immunes, la sclérose en plaques, la migraine et les infections des sinus. Les facteurs de risque supplémentaires à détecter sont l'utilisation (excessive) de lentilles de contact (kératite des lentilles de contact), la surexposition au soleil ou à la soudure ([kératite due aux ultraviolets](#)), le martelage ou le perçage de métal (corps étranger), et l'existence d'une blessure ou d'une chirurgie oculaire récente ([endophtalmie](#)).

Examen clinique

Les signes vitaux sont vérifiés en particulier la présence de fièvre. Le nez est examiné à la recherche d'une rhinorrhée purulente et la face est palpée à la recherche d'une sensibilité. Lorsque l'œil est rouge, la région prétragienne est palpée à la recherche d'adénopathie. Le respect des règles d'hygiène doit

être scrupuleux lors de l'examen de patients qui présentent un chémosis, une adénopathie prétragienne, une coloration cornéenne ponctuée ou une association de ces signes; ils suggèrent une [kératoconjonctivite épidémique](#), qui est très contagieuse.

L'examen ophtalmologique doit être aussi complet que possible en cas de douleur oculaire. L'acuité visuelle la mieux corrigée est vérifiée. Les champs visuels sont généralement testés par confrontation en cas de douleur oculaire, mais ce test peut se révéler peu sensible (en particulier pour les petites anomalies) et peu fiable par manque de coopération des sujets. Une lumière est déplacée d'un œil à l'autre pour vérifier la taille de la pupille et les réponses à la lumière, directes et consensuelles. Chez les patients qui présentent une douleur oculaire unilatérale, une lumière est dirigée vers l'œil indemne alors que l'œil atteint est fermé; une douleur dans l'œil atteint représente une photophobie vraie. Les mouvements oculaires sont vérifiés. Les structures orbitaires et péri-orbitaires sont inspectées. La rougeur conjonctivale qui semble plus intense et confluyente autour la cornée et du limbe est appelée cercle périkeratique (flush ciliaire).

L'examen ophtalmologique comprendra l'évaluation de structures spécifiques d'intérêt, selon les indications de l'anamnèse du patient. Par exemple, un examen à la lampe à fente est effectué pour évaluer la cornée et la chambre antérieure en cas de suspicion d'abrasion cornéenne, d'ulcère ou de corps étranger. La cornée est colorée avec la fluorescéine et examinée sous grossissement avec la lumière bleu cobalt. Si on ne dispose pas de lampe à fente, la cornée peut être examinée après coloration à la fluorescéine en lumière de Wood avec grossissement. L'ophtalmoscopie est effectuée pour examiner la chambre postérieure et la rétine en cas de suspicion d'inflammation grave ou d'infection. Les pressions intraoculaires sont mesurées (tonométrie) pour détecter un glaucome par fermeture de l'angle aigu. Chez les patients qui se plaignent d'une sensation de corps étranger ou ont des érosions cornéennes inexpliquées, les paupières sont retournées et examinées à la recherche de corps étrangers.

Signes d'alarme

Les signes suivants sont particulièrement préoccupants:

- Des vomissements, des halos autour des lumières ou un œdème cornéen
- Des signes généraux d'infection (p. ex., fièvre, frissons)
- Une diminution de l'acuité visuelle
- Une exophtalmie
- Une diminution de la motilité oculaire extrinsèque

Interprétation des signes

Les signes évocateurs sont listés dans le tableau [Certaines causes de douleur oculaire](#). Certains signes sont plus évocateurs de types spécifiques de troubles.

Un prurit ou une sensation de corps étranger sont le plus souvent provoqués par des atteintes des paupières, des conjonctives ou de la surface de la cornée. Une photosensibilité est possible.

Une douleur de surface avec photophobie est souvent accompagnée de sensation de [corps étranger](#) et de douleur au clignement; elle suggère une lésion cornéenne, le plus souvent un corps étranger ou une érosion.

Une douleur plus profonde, souvent décrite comme sourde ou pulsatile, indique habituellement une maladie grave telle qu'un [glaucome](#), une [uvéïte](#), une [sclérite](#), une [endophtalmie](#), une [cellulite orbitaire](#) ou une pseudotumeur orbitaire. Dans ce groupe, un œdème des paupières et/ou une exophtalmie ainsi qu'une limitation des mouvements oculaires ou de l'acuité visuelle suggèrent une pseudotumeur orbitaire, une cellulite orbitaire ou peut-être une endophtalmie grave. De la fièvre, des frissons et une sensibilité évoquent une infection (p. ex., cellulite orbitaire, [sinusite](#), sepsis).

Un œil rouge suggère que l'affection provoquant la douleur est oculaire plutôt qu'une autre affection avec douleur projetée.

Si la douleur se développe dans l'œil atteint en réponse à l'éclairage de l'œil indemne lorsque l'œil atteint est fermé (photophobie vraie), la cause est le plus souvent une lésion cornéenne ou une uvéïte.

Une rougeur ciliaire suggère que l'inflammation est intra-oculaire (p. ex., en raison d'une uvéïte ou d'un glaucome) et non dans la conjonctive.

Si un collyre anesthésique (p. ex., proparacaine) abolit la douleur d'un œil rouge, la cause en est probablement une affection cornéenne.

Une douleur et une photophobie quelques jours après un traumatisme contondant de l'œil suggèrent une uvéïte post-traumatique. Le martelage ou le perçage de métaux sont des facteurs de risque de corps étranger métallique intra-oculaire occulte. La douleur lors des mouvements des muscles oculomoteurs et la perte de la réponse pupillaire à la lumière disproportionnée par rapport à la perte de l'acuité visuelle suggèrent une névrite optique.

Examens complémentaires

Les tests ne sont généralement pas nécessaires, à quelques exceptions près (voir tableau [Certaines causes de douleur oculaire](#)). Une gonioscopie est effectuée si le [glaucome](#) est suspecté sur l'augmentation de la pression intraoculaire. Une imagerie, habituellement par la TDM ou l'IRM, est obtenue si l'on suspecte une pseudotumeur ou une [cellulite orbitaire](#) ou si la [sinusite](#) est suspectée mais que le diagnostic n'est pas cliniquement clairement établi. Lorsqu'une névrite optique est suspectée, une IRM doit être réalisée pour rechercher des lésions démyélinisantes cérébrales évocatrices de [sclérose en plaques](#).

Les liquides intraoculaires (vitré et humeur aqueuse) peuvent être mis en culture si l'on suspecte une [endophtalmie](#). Des cultures virales peuvent être utilisées afin de confirmer un [zona ophtalmique](#) (herpes zoster) ou une [kératite herpétique](#) lorsque le diagnostic n'est pas cliniquement évident.

Traitement de la douleur oculaire

La cause de la douleur est traitée. La douleur elle-même est également traitée. Les antalgiques généraux sont utilisés si nécessaire. La douleur provoquée par une uvéïte et par de nombreuses lésions cornéennes est également soulagée par un collyre cycloplégique (p. ex., cyclopentolate).

Points clés

- La plupart des diagnostics peuvent être établis par l'examen ophtalmologique.
- Les précautions anti-épidémiques doivent être maintenues lorsqu'on examine les patients qui présentent des yeux rouges des deux côtés.
- Les signes de grand danger sont les vomissements, la perception de halos autour des lumières, une fièvre, une diminution de l'acuité visuelle, une exophtalmie et une altération de la motricité oculaire.
- Une douleur de l'œil malade en réponse à l'éclairage de l'œil indemne alors que l'œil malade est fermé (photophobie vraie) suggère une lésion cornéenne ou une uvéïte.
- Lorsqu'un anesthésique local (p. ex., proparacaine) soulage la douleur, la cause probable de cette douleur est une lésion cornéenne.
- Le martelage ou le perçage de métal est un facteur de risque de corps étrangers intra-oculaire occultes.



Copyright © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, États-Unis et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.